HELP_Organi_P10 — Groupe B — Lots 227 à 231 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 10 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

B-025 — Haute — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 (réactivation VHB) › tableau des classes de risque et diagnostics différentiels

Contexte : Le cours donne les classes de risque de réactivation (modéré 1 à 10 %, faible < 1 %) sans exemples de médicaments. Il n'a pas trouvé le rôle des IgM anti-HBc dans la réactivation.

Question : Selon la recommandation EASL la plus récente sur l'hépatite B (2025 ou ultérieure) et toute recommandation suisse (SASL, SSG), quels médicaments relèvent des classes de risque élevé, modéré et faible ? Quelle prophylaxie antivirale faut-il pour chaque classe (molécule, dose, durée après la fin du traitement) ? Les IgM anti-HBc peuvent-elles réapparaître lors d'une réactivation ? Donne les différences avec la version citée.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-017 — Moyenne — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › épidémiologie (« 42 750 nouveaux cancers par an », « présentation tardive ») ; Partie 1 › DX.2 › fenêtre « Swiss HIV Cohort Study (SHCS) » ; Partie 4 › DX.9 › diagnostic différentiel VIH

Contexte : Le cours borne la population exposée par le nombre de nouveaux cancers et les cohortes de greffés. Il n'a trouvé ni l'incidence suisse de la neutropénie fébrile, ni la prévalence des patients immunosupprimés, ni le nombre de diagnostics VIH en 2024-2025.

Question : Quel est le nombre de nouveaux diagnostics VIH déclarés en Suisse en 2024 et en 2025 (OFSP, bulletin ou rapport annuel), avec la part des présentations tardives ? Quelle est la stratégie de dépistage du VIH recommandée par l'OFSP (test, indications) ? Existe-t-il une estimation suisse de la prévalence des patients immunosupprimés et de l'incidence de la neutropénie fébrile ? Donne les URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-018 — Moyenne — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 (neutropénie fébrile) › fenêtre « céfidérocol »

Contexte : Le cours cite le céfidérocol et n'a trouvé aucun essai suisse en recrutement.

Question : Le céfidérocol (Fetcroja®) est-il autorisé par Swissmedic et inscrit sur la Liste des spécialités ? Donne ses indications, sa posologie et son adaptation rénale selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch). Quelle place lui donne la recommandation européenne la plus récente dans la neutropénie fébrile (ECIL, ESCMID) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-027 — Moyenne — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau IgG, IgA, IgM et ligne DX.10 (DICV)

Contexte : Le cours retient IgG < 5 g/l chez la plupart des adultes avec DICV, des B mémoire commutés < 70 % et une substitution en IgG, sans le germe typique ni la dose de substitution.

Question : Selon les critères ESID les plus récents, quelles valeurs d'IgG, d'IgA et d'IgM et quelle réponse vaccinale définissent le DICV ? Quels germes provoquent typiquement ses infections sino-pulmonaires ? Quelles doses de substitution en IgG (IV et SC) recommande-t-on, quelle concentration résiduelle cible et quelle spécialité suisse (IP) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-028 — Moyenne — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › cadre légal 5 › fenêtre « CC art. 16 : la capacité de discernement »

Contexte : Le cours cite le CC art. 16 ; les directives de l'ASSM sur la capacité de discernement n'ont pas été lues.

Question : Que disent les directives médico-éthiques de l'ASSM sur l'évaluation de la capacité de discernement dans la pratique médicale (édition la plus récente, année, URL) ? Quelles étapes et quels critères proposent-elles ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-031 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 2 › fenêtres « salbutamol » et « glucagon » ; Partie 1 › DX.2 › tableau des traitements adjuvants ; Partie 3 › fiche Ventolin®

Contexte : Le cours donne le salbutamol (IP Ventolin® et Swisspeddose ; nébulisé 5 mg ou 2,5 mg selon RCUK) et le glucagon hors indication sous bêtabloquant (adulte 1 mg IV, puis 1 à 2 mg/h ; enfant 20 à 30 µg/kg). Les adaptations rénales et hépatiques des traitements adjuvants n'ont pas été trouvées.

Question : Selon les IP suisses (Ventolin®, GlucaGen®, Spiricort® ou autre corticoïde IV, antihistaminique IV disponible en Suisse), quelles doses et quelles adaptations rénales ou hépatiques s'appliquent aux traitements adjuvants de l'anaphylaxie ? Quelle dose de glucagon recommande la ligne directrice européenne la plus récente (EAACI, WAO, RCUK 2021 ou mise à jour) pour une anaphylaxie sous bêtabloquant ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-032 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableaux « IgE spécifiques, tests cutanés et composants » et « test de provocation orale » ; Partie 1 › DX.2 › seuils et critères d'arrêt de l'éviction ; Partie 2 › DX.3 › IgE bouleau/Bet v 1

Contexte : Le cours écrit que les seuils chiffrés des IgE spécifiques, du prick test, du test d'activation des basophiles et des composants (Ara h 2, Cor a 14, Ana o 3, Bet v 1) n'ont pas été trouvés. Il n'a pas trouvé la sensibilité et la spécificité de la provocation orale ni le critère d'arrêt de l'éviction.

Question : Selon la recommandation EAACI la plus récente sur le diagnostic de l'allergie alimentaire (2023 ou mise à jour) et la SSAI, quels seuils (kUA/l, diamètre de papule en mm) ont une valeur prédictive positive de 95 % pour l'arachide, la noisette et le cajou, en particulier Ara h 2 ? Quand et comment refait-on une provocation orale pour lever une éviction ? Quelles différences présente la version la plus récente avec celle de 2023 citée ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-033 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 2 › fenêtre « omalizumab » ; Partie 1 › DX.2 › tableau omalizumab

Contexte : Le cours écrit que l'EAACI 2025 suggère l'omalizumab dans l'allergie alimentaire, que l'IP suisse de Xolair® le dit insuffisamment étudié dans cette indication et que la dose n'a pas été trouvée.

Question : Au 22.10.2026, Swissmedic a-t-il autorisé Xolair® (omalizumab) dans l'allergie alimentaire IgE-médiée ? Quelle limitation de la LS s'applique ? Quelle posologie (selon les IgE totales et le poids) donne l'IP ou, à défaut, le libellé de l'EMA ou de l'EAACI 2025 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-034 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 2 › fenêtre « ésoméprazole » ; Partie 4 › DX.8 (œsophagite à éosinophiles) › alternatives (enfant, grossesse), fenêtre juridique LS, C- Surveillance

Contexte : Le cours note que Nexium® est hors indication dans l'œsophagite à éosinophiles, sans dose. Il s'appuie sur les limitations LS de Jorveza® et de Dupixent®. Il n'a trouvé ni la conduite pendant la grossesse ni le calendrier complet de surveillance.

Question : Quelle dose d'IPP (ésoméprazole, oméprazole) et quelle durée d'induction recommandent les lignes directrices européennes (EUREOS/UEG 2017 et mise à jour, ESPGHAN 2024) dans l'œsophagite à éosinophiles, chez l'adulte et chez l'enfant ? Donne la dose de Jorveza® et de Dupixent® dans cette indication selon les IP suisses. Quelle conduite recommande-t-on pendant la grossesse ? Quand faut-il refaire une endoscopie de contrôle ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-035 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableaux sérologie/biopsie, calprotectine, « Régime sans gluten déjà commencé », surveillance ; Partie 2 › DX.5 (maladie cœliaque) › étiquetage, bisphosphonate, RCD

Contexte : Le cours écrit que la durée de réintroduction du gluten avant la sérologie, le seuil de la calprotectine, le calendrier de suivi, la posologie d'Aclasta® et les spécialités suisses du traitement de la maladie cœliaque réfractaire n'ont pas été trouvés. Il juge l'étiquette « très faible teneur en gluten » déconseillée par prudence.

Question : Selon l'ESsCD 2019 (ou mise à jour), l'ESPGHAN 2020 et toute recommandation suisse (SSG, IG Zöliakie), quelle quantité de gluten faut-il réintroduire et pendant combien de temps avant la sérologie ? Quel calendrier de suivi sérologique faut-il ? Les produits à « très faible teneur en gluten » (≤ 100 mg/kg) conviennent-ils au patient cœliaque ? Quel seuil de calprotectine fécale (µg/g) retient l'UEG/ESNM pour orienter vers une MICI ? Donne la posologie d'Aclasta® dans l'ostéoporose selon l'IP suisse et les spécialités suisses de budésonide, d'azathioprine et de cladribine.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-037 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 (SII-D / FODMAP) › tableau SeHCAT et tableau des traitements (rifaximine, ondansétron)

Contexte : Le cours cite la rifaximine (Xifaxan® 550 mg 3×/j pendant 2 semaines dans les essais) et l'ondansétron (4 mg/j jusqu'à 8 mg 3×/j) hors indication dans le SII-D. Il n'a trouvé ni la posologie suisse ni le seuil normal du SeHCAT.

Question : En Suisse, la rifaximine et l'ondansétron sont-ils autorisés ou remboursés dans le SII-D (IP, LS) ? Quelles posologies recommande la ligne directrice UEG/ESNM 2021 ou sa mise à jour ? Quel seuil de rétention du SeHCAT à 7 jours définit la diarrhée des acides biliaires (< 10 %, < 15 %), et le test est-il disponible en Suisse ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-038 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › fenêtre « déclaration

des toxi-infections alimentaires » ; Bloc 2 › ligne DX.6 ; Partie 3 › DX.6 › norovirus, antibiothérapie, déclaration obligatoire

Contexte : Le cours cite l'ordonnance du DFI sur la déclaration (RS 818.101.126) sans les articles précis. Il n'a trouvé ni les durées d'incubation, ni les schémas antibiotiques de l'ESPGHAN/ESPID, ni une recommandation suisse ou de l'ESCMID.

Question : Quels articles et quelles annexes de l'ordonnance du DFI (RS 818.101.126, version en vigueur) fixent la déclaration de Campylobacter, Salmonella, STEC, Listeria et des foyers de toxi-infection (délai, déclarant) ? Quelles sont les durées d'incubation de Campylobacter, Salmonella, STEC, norovirus, S. aureus et B. cereus ? Quand et avec quels antibiotiques (molécule, dose, durée) faut-il traiter une gastro-entérite bactérienne chez l'adulte et chez l'enfant (SSI, ESPGHAN/ESPID 2014 ou mise à jour) ? Rappelle la contre-indication des antibiotiques dans l'infection à STEC.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-039 — Haute — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 (APLV/FPIES) › fiche « Ondansétron — FPIES »

Contexte : Le cours reprend la posologie du groupe français (dès 6 mois et 8 kg) : per os 2, 4 ou 8 mg selon le poids, IV 0,15 mg/kg (maximum 8 mg). Il note que l'usage est hors indication en Suisse et que l'adaptation rénale n'a pas été trouvée.

Question : Quelle conduite face à une crise aiguë de FPIES recommandent le consensus international et toute recommandation suisse ou européenne récente (SSP/SGP, EAACI, ESPGHAN) ? Donne la dose d'ondansétron, l'âge minimal et le remplissage. Quelles adaptations rénales et hépatiques donne l'IP suisse de Zofran® ? Quelle formule de remplacement recommande la SSP pour l'APLV du nourrisson ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-029 — Moyenne — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › tableau épidémiologique et fenêtre « chiffres écartés » ; Partie 2 › DX.3-DX.4 › tableaux des chiffres ; Partie 4 › DX.9-DX.10 › prévalence

Contexte : Le cours n'a trouvé aucune prévalence suisse du SII, de la sensibilité au gluten non cœliaque, du syndrome pollen-aliment ni de l'intoxication scombroïde. Il cite un chiffre multinational du SII-D (0,4 à 1,2 %) et environ 1 % de maladie cœliaque en Suisse.

Question : Quelles prévalences suisses (ou, à défaut, européennes récentes) existent pour le SII selon Rome IV, la sensibilité au gluten ou au blé non cœliaque, le syndrome pollen-aliment et l'intoxication scombroïde (déclarations OSAV/OFSP) ? Donne la source, l'année, la population et l'URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-036 — Moyenne — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 2 › tableau « Lactase et DAO orales » ; Partie 1 › DX.1 (lactose) › grossesse, lactase, probiotiques, recherche 2026

Contexte : Le cours écrit qu'aucune spécialité suisse de lactase n'est enregistrée (compléments alimentaires) et que la dose des probiotiques, l'adaptation du test respiratoire pendant la grossesse et les données d'enregistrement de l'essai GOS RP-G28 n'ont pas été trouvées.

Question : Quels produits de lactase sont vendus en Suisse (statut : complément alimentaire ou médicament) et quelle dose (unités FCC par gramme de lactose) recommande-t-on ? Le test respiratoire à l'hydrogène est-il réalisable pendant la grossesse ? Quels probiotiques, à quelle dose, ont été étudiés dans l'intolérance au lactose ? Donne le numéro d'enregistrement et la phase de l'essai RP-G28.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-040 — Moyenne — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.9 (histamine/scombroïde) › critères, gold standard, test « histamine 50 », alternatives, tableau des traitements (anti-H2, DAO)

Contexte : Le cours écrit qu'aucune société savante ne publie de critères formels de l'intoxication scombroïde, que la DAO n'est pas recommandée par la guideline DGAKI/SGAI et qu'aucun anti-H2 n'est inscrit sur la LS.

Question : Quelle conduite (antihistaminique H1 et H2, molécule, dose) recommande-t-on pour l'intoxication scombroïde selon une source suisse ou européenne récente ? Quel anti-H2 reste disponible en Suisse (Swissmedic, au 22.10.2026) ? La guideline DGAKI/SGAI sur l'histamine (édition la plus récente) a-t-elle changé de position sur la DAO et sur le test « histamine 50 » ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-041 — Moyenne — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 2 › ligne DX.10 ; Partie

4 › DX.10 (gluten/blé non cœliaque) › gold standard, alternatives, traitement, surveillance

Contexte : Le cours suit les critères de Salerno (provocation à 8 g/j de gluten, variation ≥ 30 %). Il n'a trouvé ni le délai d'apparition des symptômes, ni la conduite pendant la grossesse, ni un traitement validé, ni un suivi spécifique.

Question : Les critères de Salerno (2015) restent-ils la référence en 2026, ou une recommandation européenne plus récente les remplace-t-elle ? Quel délai d'apparition des symptômes retient-on après l'ingestion de gluten ? Quelle conduite diététique et quel suivi recommande-t-on ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-043 — Haute — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 (dépression somatisée) › critères, ligne « Grossesse », B- Moyens non médicamenteux

Contexte : Le cours écrit que la ligne directrice suisse de la dépression de 2016 n'a pas pu être lue (critères, protocole de psychothérapie) et que la recommandation suisse de la dépression pendant la grossesse n'a pas été trouvée.

Question : Quelle est la recommandation suisse en vigueur pour le traitement de la dépression unipolaire (SSAD/SGAD, SSPP/SGPP, Swiss Medical Forum ; version 2016 ou mise à jour) ? Donne le titre, l'année, l'URL et les différences avec la version de 2016. Quelle recommandation suisse ou européenne encadre la dépression pendant la grossesse et l'allaitement (choix de l'ISRS, sertraline, surveillance du nouveau-né) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-044 — Haute — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › seuils biologiques ; Partie 1 › fenêtre « ECG et électrolytes avant escitalopram », C- Surveillance ; Partie 2 › DX.4-DX.5 › biologie (ISRS, lopéramide)

Contexte : Le cours écrit que l'escitalopram est contre-indiqué en cas de QT long et que la sertraline expose à l'hyponatrémie (cas < 110 mmol/L). Il n'a trouvé ni seuil de QTc ni calendrier de contrôle (J3, J7, M1) ni seuil d'arrêt.

Question : Selon les IP suisses de Cipralex® (escitalopram) et de Zoloft® (sertraline), quelle valeur de QTc impose l'arrêt ou contre-indique le traitement ? Quelle natrémie faut-il contrôler, chez quels patients et à quelles échéances (recommandation suisse ou européenne) ? Quelle surveillance ECG s'impose sous lopéramide à forte dose selon l'IP suisse d'Imodium® ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-045 — Haute — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 2 › tableau Zoloft® ; Partie 2 › DX.4 › tableau des autres antidépresseurs (SSAD 2024) ; Partie 4 › DX.9 › tableau Zoloft®

Contexte : Le cours donne la sertraline (dépression 50 à 200 mg/j ; panique 25 mg puis 50 mg ; demi-dose en insuffisance hépatique) et les doses SSAD 2024 du trouble panique (citalopram, paroxétine, venlafaxine, clomipramine). Il n'a vérifié ni les spécialités suisses ni les contre-indications, et il n'a pas repris les doses du TAG.

Question : Selon les IP suisses, quelles spécialités, quelles doses, quelles contre-indications et quelles adaptations rénales et hépatiques s'appliquent au citalopram, à la paroxétine, à la venlafaxine, à l'escitalopram et à la clomipramine dans le trouble panique et le TAG ? Quelles doses recommande la recommandation suisse SSAD 2024 pour le TAG ? Vérifie l'adaptation rénale de la sertraline dans l'IP de Zoloft®.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P10 — 20 questions : B-025, B-017, B-018, B-027, B-028, B-031, B-032, B-033, B-034, B-035, B-037, B-038, B-039, B-029, B-036, B-040, B-041, B-043, B-044, B-045